

참아야 할 증상과 연락해야 할 증상

대부분의 불편감은 조절 가능하지만, 심한 복통·탈수·저혈당·알레르기 증상은 빠른 판단이 필요합니다.

심한 복통은 단순 소화불량으로 넘기지 않습니다

췌장염과 담낭질환은 드물지만 반드시 확인해야 하는 위험 신호입니다.

상복부 통증이 심하고 지속되거나 등으로 퍼지고, 구토가 반복되면 즉시 연락합니다. 우상복부 통증·발열·황달도 진료가 필요합니다.

PANCREAS

췌장염 의심

심한 지속 상복부 통증, 등으로 퍼지는 통증, 반복 구토.

GALLBLADDER

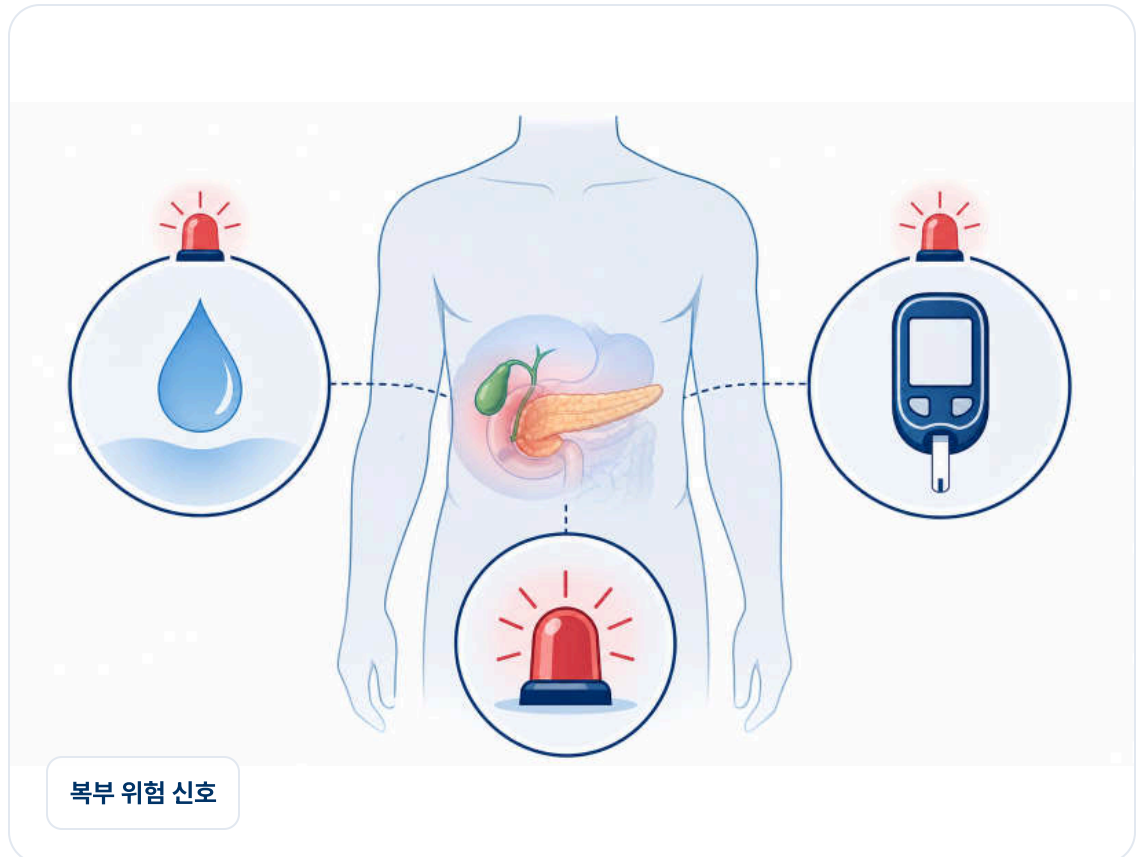
담낭질환

우상복부 통증, 발열, 노란 눈·소변 색 변화.

ACTION

행동

증상을 참으며 다음 주사를 맞지 말고 먼저 진료에 알립니다.



구토·설사가 오래가면 약보다 수분이 먼저입니다

탈수는 어지럼, 신장기능 악화, 심한 무기력으로 이어질 수 있습니다.



탈수 예방

물을 못 마시고 토하거나 설사가 계속되면 치료를 잠시 조정해야 할 수 있습니다. 소변량 감소와 어지럼은 중요한 신호입니다.

URINE

소변 감소

반나절 이상 소변이 매우 적거나 진하면 연락합니다.

DIZZY

어지럼

서 있을 때 핑 돌거나 심장이 두근거리면 탈수를 의심합니다.

MEDS

동반약

이뇨제·혈압약·당뇨약 복용자는 더 빨리 상담이 필요할 수 있습니다.

당뇨약을 같이 쓰면 저혈당을 확인합니다

GLP-1 계열 자체보다 인슐린·설폰요소제 병용 시 저혈당 위험이 올라갑니다.

식사량이 줄면 기존 당뇨약 용량이 상대적으로 강해질 수 있습니다.
떨림, 식은땀, 심한 허기, 혼란감이 있으면 혈당 확인이 필요합니다.

SYMPTOM

증상

식은땀, 손떨림, 심한 배고픔, 두근거림, 멍함.

CHECK

측정

가능하면 혈당을 재고, 반복되면 약 조정을 상담합니다.

RISK

고위험 약

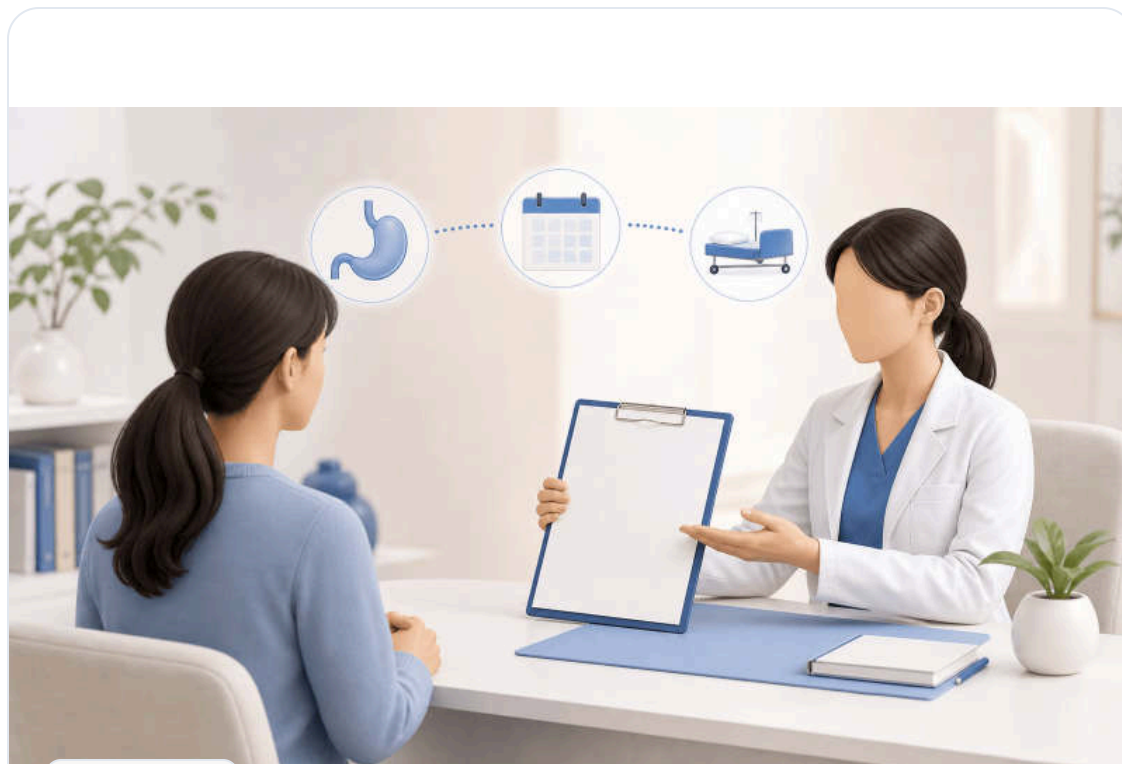
인슐린과 설폰요소제는 특히 진료실에 알려야 합니다.



혈당·약물 확인

수술·수면마취 전에는 주사약을 반드시 알립니다

위 배출 지연 때문에 마취·시술 전 관리 계획이 달라질 수 있습니다.



진료 전 알리기

내시경, 수술, 수면마취 예정이 있으면 약 이름과 마지막 주사일을 의료진에게 말해야 합니다. 갑상선 수질암/MEN2 병력도 처방 전 반드시 확인합니다.

PROCEDURE

시술 전

내시경·수술·마취 전 약 이름과 마지막 주사일을 알립니다.

THYROID

갑상선 병력

갑상선 수질암 또는 MEN2 개인·가족력은 중요한 금기입니다.

ALLERGY

알레르기

호흡곤란, 얼굴·입술 부종, 전신 두드러기는 즉시 진료가 필요합니다.

이번 회차는 빨간불 구분

이번 주는 증상 이름보다 '지속성·강도·탈수 여부'를 기준으로 판단합니다.

01 심한 지속 복통과 반복 구토는 **바로 연락**합니다.

02 구토·설사가 지속되면 탈수와 신장기능을 봐야 합니다.

03 당뇨약 병용 시 저혈당 증상을 놓치지 않습니다.

04 시술·마취 전에는 마지막 주사일을 꼭 알립니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요